



FICHA DE INGRESO PSIQUIATRÍA INFANTO-JUVENIL

Conforme a normativa chilena – Uso Clínico

IDENTIFICACIÓN DEL PACIENTE

- Nombre: Joaquín Alfonso Verdugo Leiva
- RUN: 23.043.624-k
- Fecha de nacimiento: 5 de junio de 2009
- Edad: 17 años
- Sexo: masculino
- Escolaridad:
- Establecimiento educacional: Sagrado Corazón de La Reina
- Nombre del cuidador/tutor legal: Cristian Verdugo
- Contacto:

2. MOTIVO DE CONSULTA

- Descripción del motivo de consulta: padre refiere requerir ayuda con alteración ciclo sueño vigilia y con dificultades en conducta y asistencia escolar.
- Tiempo de evolución:

Se entrevista en primera instancia a padre quien da cuenta de antecedente de denuncia por vulneración de derechos a ambos padres de parte del colegio, luego de “forcejeo” por negación de Joaquín de asistir a clases. Luego de esto padre describe que Joaquín altera su sueño debido a que deja de asistir a clases, en la noche come, juega videojuegos, en el día duerme. Impresiona padre con dificultad para borrar situación ya que teme por otra denuncia. Con diagnóstico reciente de TEA en psicoeduca, padre refiere que está empezando a entender conductas de Joaquín desde hace poco, intenta comprenderlo y adquirir herramientas.

Pare reporta deterioro en salud mental de ambos padres, impresiona enrabado, con sensación de presentar pocas herramientas; la madre presenta depresión y ansiedad, en tratamiento farmacológico ambos, padre describe crisis de pánico.

Padre refiere que principal dificultad a nivel familiar se da por resistencia de Joaquín a los cambios de rutina, lo que genera tensiones ante viajes o actividades no planificadas. La familia no cuenta con redes de apoyo cercanas en la ciudad de Santiago.

Joaquín lleva 30 días sin asistir a clases, se encuentra con riesgo de repitencia por inasistencia. Se le pidió al colegio reducción de jornada escolar, aun no se hace efectiva.

El padre manifiesta que el colegio ha mostrado una actitud pasiva y poco colaborativa ante las solicitudes de adecuación realizadas por el centro terapéutico.

A entrevista con Joaquín: relata una profunda desconfianza hacia sus pares debido a experiencias previas de traición por parte de amigos cercanos y episodios de acoso escolar relacionados con su exclusión por ser malo para el fútbol, describe a .a sus compañeros como inmaduros y describe que los demás son un problema, no identifica dificultades en el mismo. Describe a su madre como afectiva, puede contarle sus problemas, y a su padre como mas “proveedor”.

Se indaga en conocimiento acerca de su diagnóstico de TEA, refiere de manera muy clara que si cree que esta dentro del espectro porque describe que desde pequeño posee un lenguaje formal y sofisticado, no presenta mismos temas de interés con sus pares, a veces siente que no encaja. Describe luego una serie de dificultades cuando padres lo sacan de la rutina que él tenía prevista ¿, en especial con los viajes a la playa En donde describe queda “pegado” en lo que el tenía pensado hacer y que le generaron cambios a última hora, además de dificultades sensoriales alla, como el tener que andar en metro, sentirse en un lugar lleno de gente, la cama de alla es incomoda, el espacio es mas pequeño, dice que no tolera el frio. En metro o en la calle describe estado de hipervigilancia constante, percibiendo el entorno social y físico como una amenaza potencial. Refiere tiende a “sobrepensar” y quedarse pegado en sus pensamientos. Destaca que al indagar en sus emociones, o como vive las situaciones de exclusión social tiende a racionalizarlo y poner el problema en los otros, con dificultad para conectar con sus emociones, finalmente reconoce haber sentido pena, pocas ganas de vivir en algún momento pero nunca ideación suicida, ni pensamientos de autodaño. Presenta proyección futura, desea ir a la universidad estudiar informática o derecho. Se plantea como primera meta terminar colegio, dese ahí planteo adherir a terapias y a controles de salud mental para poder apoyarlo para alcanzar sus metas, se muestra de acuerdo. Luego realizo extensa psicoeducación en higiene del sueño y en estrategias para disminuir tiempo en pantallas.

3. ANTECEDENTES PSIQUIÁTRICOS PERSONALES

- Diagnósticos previos: Antecedente de diagnóstico de TEA reciente, este año
- Hospitalizaciones previas: no
- Tratamientos farmacológicos: no
- Psicoterapia previa: se encuentra actualmente en psicoterapia en psicoeduka
- Conductas autolesivas / ideación suicida: no y no

4. ANTECEDENTES MÉDICOS GENERALES

- Patologías médicas relevantes: sano
- Tratamientos actuales: no
- Alergias: no

5. ANTECEDENTES FAMILIARES

- Antecedentes psiquiátricos familiares: no
- Contexto psicosocial relevante: vive actualmente con ambos padres y hermana, padre refiere no presentan mas red de apoyo en Santiago, familiares están en otras ciudades. Padre describe que tanto el como madre se encuentran en atenciones con psiquiatra.

6. EVALUACIÓN DEL ESTADO MENTAL

- Apariencia: constitución mesomorfa, acorde a edad cronológica, vestimenta e higiene adecuada.
- Actitud: cooperador, a rato actitud pedante en relación a los otros
- Psicomotricidad: se observa disminuida
- Lenguaje: Notificativo, atingente, sin alteraciones en estructura.
- Pensamiento: Sin alteraciones formales, niega delirios y niega alteraciones sensoriales hoy. Contenido en relación a dificultades con pares y padres
- Ánimo impresiona eutímico
- Contacto visual adecuado
- Juicio de realidad: conservado, no psicótico.
- Insight: no, dificultad para introspección

7. EVALUACIÓN DE RIESGO

- Riesgo suicida: no actualmente
- Factores de riesgo: poca capacidad de introspección, dificultad para conectar con sus emociones y en capacidad de mentalizar al otro y automentalización. Dificultades con padres quienes impresiona se sienten con pocas herramientas, riesgo de MI y de perpetuar t. vincular . Exceso de tiempo en pantallas, dificultad de habilidades sociales.
- Factores protectores: buen nivel cognitivo, presenta metas claras, eutimia, presencia de intereses presente.

8. IMPRESIÓN DIAGNÓSTICA (DSM-5 / CIE-11)

- Diagnóstico principal: TEA,
- Diagnósticos secundarios: t. Sueño, disfunción familiar? T vincular?? Riesgo desercion escolar

9. PLAN TERAPÉUTICO

- Tratamiento farmacológico: quetiapina 25 mg 0-0-½ y azymol 5 mg 1-0-0 (este último como apoyo en tendencia a rigidez cognitiva, estados paranoides, tendencia irritabilidad y cambios de humor)

- Intervenciones psicosociales: énfasis en higiene del sueño y uso sano de pantallas, se motiva a crear lista de intereses, llevarlos a cabo sin implicancia de pantallas (se muestra de acuerdo)
- Derivaciones: psicoterapia, TO

10. SEGUIMIENTO

- Fecha próximo control: 3 semanas
- Red de apoyo: padres
- Indicaciones a cuidadores: se hace entrega de diagnóstico y observación de dificultades, áreas a trabajar y se psicoeduca con respecto a rol de fármacos.

11. DATOS DEL PROFESIONAL

Nombre: Caterina Schiappacasse Arteaga

Especialidad: psiquiatra infanto juvenil

Registro profesional: 105595

Centro de atención: Psicoeduka Santiago

Fecha: 2026